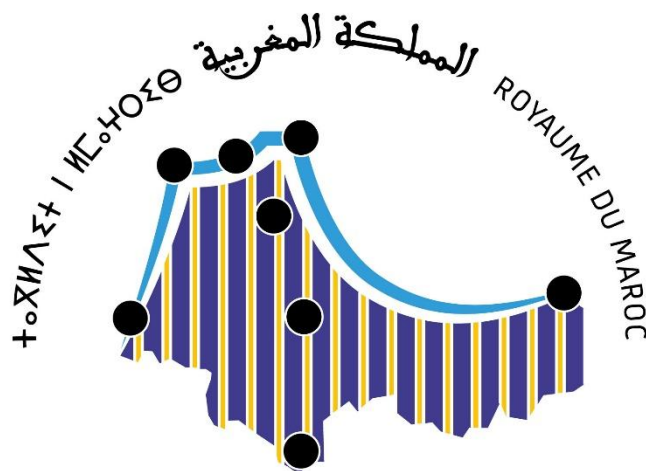


Concours



جهة الحسمة - تطولن - الحسمة

ⵜⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ - ⵜⴰⵖⴻⵔⵓⵏⵜ - ⵏ ⵏⵓⵄⵉⵎⴰ

RÉGION TANGER-TÉTOUAN-AL HOCEIMA

Commun 2023 – Epreuve 1
Avec Justification



[Lien Page Instagram](#)

PRÉPA
CONCOURS
MSPS



OFFRE DE PRÉPARATION AU CONCOURS DE
RECRUTEMENT- INSCRIPTION OUVERTE

1. La santé est relative au bien-être :

- A. Physique, mental ou social
- B. Physique, mental et social
- C. Mental et social
- D. Physique et social

2. L'action de l'État dans le domaine de la santé tend à œuvrer pour :

- A. Réaliser la sécurité sanitaire et protéger la santé de la population
- B. Prémunir les individus contre les maladies, les épidémies et les risques menaçant leur vie
- C. Garantir la vie dans un environnement sain
- D. Centraliser les actions sanitaires

3. Le secteur sanitaire public est :

- A. Mutualiste
- B. Libéral
- C. Étatique
- D. Financé par le budget de l'État

4. Le secteur sanitaire privé à but lucratif produit :

- A. Les services de santé marchands
- B. Les services de santé non marchands
- C. Les services de santé mobiles
- D. Les services de santé curatifs

5. Le système national de santé est basé sur les principes suivants :

- A. L'égalité d'accès aux soins et aux prestations de santé
- B. La continuité des prestations de santé
- C. La subsidiarité
- D. La bonne gouvernance

6. Le système national de santé est composé de :

- A. 2 secteurs sanitaires
- B. 3 secteurs sanitaires
- C. 4 secteurs sanitaires
- D. 5 secteurs sanitaires

7. Le cabinet paramédical fait partie du :

- A. Secteur sanitaire privé à but non lucratif
- B. Secteur sanitaire privé à but lucratif



- C. Secteur sanitaire public
- D. Secteur traditionnel

8. L'organisation et la gestion des établissements de santé doivent obéir aux principes, normes et règles suivants :

- A. Les normes de sécurité des usagers
- B. Les droits fondamentaux des personnes
- C. Les règles de déontologie applicables à chaque profession
- D. Les normes et standards de qualité

9. Le secteur sanitaire public est composé de :

- A. 2 réseaux
- B. 3 réseaux
- C. 4 réseaux
- D. 5 réseaux

10. La circonscription sanitaire rurale est le territoire :

- A. D'une commune
- B. D'un cercle
- C. D'un centre
- D. D'un caïdat

11. L'offre de soins est composée :

- A. Des infrastructures sanitaires
- B. Des ressources financières
- C. Des équipements
- D. Des ressources humaines

12. Le centre de santé rural niveau 2 est implanté pour une population de plus de :

- A. 15 000 habitants
- B. 20 000 habitants
- C. 25 000 habitants
- D. 30 000 habitants

13. Le professionnel de santé peut être en position :

- A. D'activité
- B. De maladie
- C. De mise en disponibilité
- D. De détachement

14. Les examens d'échographie sont assurés dans un :

- A. Centre de santé rural niveau 1
- B. Centre de santé urbain niveau 1
- C. Centre de santé urbain niveau 2
- D. Centre de santé rural niveau 2

15. L'institut national d'hygiène est :

- A. Une structure spécialisée au réseau des ESSP
- B. Une structure spécialisée au réseau hospitalier
- C. Un établissement médicosocial
- D. Un établissement à caractère national

16. Le groupement sanitaire de territoire est :

- A. Établissement public
- B. Établissement privé à but non lucratif
- C. Établissement à caractère régional
- D. Établissement privé à but lucratif

17. Le groupement sanitaire de territoire comporte :

- A. Les établissements hospitaliers militaires
- B. Les B.C.H
- C. Les établissements des soins de santé primaires
- D. Les établissements hospitaliers publics

18. Le groupement sanitaire de territoire met en application la politique de l'État dans :

- A. Quatre domaines
- B. Cinq domaines
- C. Six domaines
- D. Sept domaines

19. Le groupement sanitaire de territoire assure :

- A. La formation initiale pour les étudiants de médecine et des ISPITS
- B. La formation pratique initiale pour les étudiants de médecine
- C. La formation pratique initiale pour les étudiants des ISPITS
- D. La formation continue des professionnels de santé du GST

20. Le groupement sanitaire de territoire est dirigé par :

- A. Un conseil d'établissement
- B. Un conseil d'administration



- C. Un conseil de sages
- D. Un conseil consultatif

21. Le centre hospitalier régional assure les prestations hospitalières de :

- A. Premier niveau
- B. Deuxième niveau
- C. Troisième niveau
- D. Quatrième niveau

22. Les urgences médicales de proximité sont assurées dans un :

- A. Centre de santé rural niveau 2
- B. Hôpital de proximité
- C. Centre de santé rural niveau 2 implanté au chef-lieu du cercle
- D. Hôpital provincial

23. Le centre hospitalier régional assure les urgences médicales :

- A. De proximité
- B. De base
- C. Complètes
- D. Spécialisées

24. Le centre de diagnostic et de traitement des maladies respiratoires est une structure spécialisée d'appui au réseau :

- A. Des établissements de soins de santé primaires
- B. Hospitalier
- C. RISUM
- D. Médico-social

25. Le centre régional de transfusion sanguine est une structure spécialisée d'appui du réseau :

- A. Des établissements de soins de santé primaires
- B. Hospitalier
- C. Médico-social
- D. RISUM

26. Les directions centrales du ministère de la Santé sont au nombre de :

- A. 4
- B. 6
- C. 8
- D. 10

27. Les urgences pré-hospitalières sont assurées au niveau :

- A. D'un hôpital de proximité
- B. D'un hôpital provincial
- C. Des moyens de transport des blessés
- D. De centre de santé urbain niveau 2

28. Face à un problème de santé publique, on adopte des approches dont :

- A. L'approche épidémiologique
- B. L'approche économique
- C. L'approche médicale
- D. L'approche individuelle

29. L'étude du financement des services de santé consiste à analyser :

- A. Les sources du financement par structure
- B. Les sources du financement par nature
- C. Les ressources humaines
- D. Les dépenses fonctionnelles de santé

30. L'assurance maladie est un dispositif chargé d'assurer un individu face à des risques :

- A. Financiers d'accident
- B. Financiers de soins
- C. Financiers de vie
- D. Financiers de perte d'emploi

31. La mortalité infantile est relative aux :

- A. Décès de moins d'un an
- B. Décès de 01 à 02 ans
- C. Décès de 02 à 03 ans
- D. Décès de 03 à 04 ans

32. La mortalité juvénile est relative aux :

- A. Décès de moins de 05 ans
- B. Décès de 01 à 05 ans
- C. Décès de 05 à 10 ans
- D. Décès de 10 à 15 ans

33. La mortalité maternelle est imputée à :

- A. La grossesse seulement
- B. La grossesse et à l'accouchement



- C. L'accouchement seulement
- D. Ni à la grossesse ni à l'accouchement

34. La filière de soins est :

- A. Une organisation horizontale des soins
- B. Une organisation verticale des soins
- C. Une organisation hiérarchisée du parcours de patient
- D. Un réseau coordonné des soins

35. L'incidence d'une maladie est relative aux :

- A. Anciens cas enregistrés
- B. Nouveaux et aux anciens cas enregistrés
- C. Nouveaux cas enregistrés
- D. Ni aux nouveaux ni aux anciens cas enregistrés

36. La létalité exprime les décès :

- A. Par âge
- B. Par sexe
- C. À cause d'une maladie
- D. Intra hospitaliers

37. Le calcul du taux d'occupation moyen d'un hôpital dépend :

- A. Du nombre de malades admis
- B. Des journées d'hospitalisation
- C. De la capacité litière
- D. Du nombre de personnels

38. La protection sociale couvre :

- A. L'assurance du patrimoine
- B. L'assurance vie
- C. L'assurance maladie
- D. Les allocations familiales

39. Parmi les droits du patient, on a :

- A. Le droit à l'information
- B. Le droit à l'accès aux soins de qualité
- C. Le droit au respect du secret professionnel
- D. Le droit au consentement

40. Les règles professionnelles sont des règles :

- A. Sociales
- B. Déontologiques
- C. Juridiques
- D. Morales



1. La santé est relative au bien-être :

- A. Physique, mental ou social
- B. Physique, mental et social
- C. Mental et social
- D. Physique et social

2. L'action de l'État dans le domaine de la santé tend à œuvrer pour :

- A. Réaliser la sécurité sanitaire et protéger la santé de la population
- B. Prémunir les individus contre les maladies, les épidémies et les risques menaçant leur vie
- C. Garantir la vie dans un environnement sain
- D. Centraliser les actions sanitaires

3. Le secteur sanitaire public est :

- A. Mutualiste
- B. Libéral
- C. Étatique
- D. Financé par le budget de l'État

4. Le secteur sanitaire privé à but lucratif produit :

- A. Les services de santé marchands
- B. Les services de santé non marchands
- C. Les services de santé mobiles
- D. Les services de santé curatifs





LE DISPOSITIF DE L'OFFRE DE SOINS AU MAROC :

2. ORGANISATION PAR MODE DE COUVERTURE SANITAIRE :



5. Le système national de santé est basé sur les principes suivants :

- A. L'égalité d'accès aux soins et aux prestations de santé
- B. La continuité des prestations de santé
- C. La subsidiarité
- D. La bonne gouvernance

6. Le système national de santé est composé de :

- A. 2 secteurs sanitaires
- B. 3 secteurs sanitaires
- C. 4 secteurs sanitaires
- D. 5 secteurs sanitaires



Organisation du système national de santé :

Le SNS Marocain est caractérisé par l'existence en général de **4 secteurs** qui sont :

- 1) **Secteur sanitaire public (Etatique) ;**
- 2) **Secteur sanitaire privé à but non lucratif (Secteur semi-public) ;**
- 3) **Secteur sanitaire privé à but lucratif (secteur privé) ;**
- 4) **Secteur traditionnel (non officiel – informel).**

• **Secteur sanitaire public (Etatique) :**

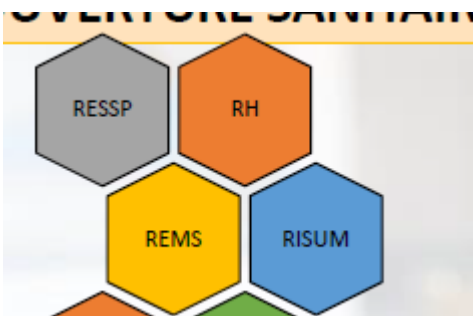
- 1) **Le MS** est responsable du maintien, de la protection et de la promotion de la santé des citoyens. Il représente l'instrument de l'Etat dans le domaine de la santé. Il s'adresse à la quasi-totalité de la population sans exception. Il est souvent l'unique recours dans le milieu rural.
- 2) **Le service de la santé des FAR** qui s'occupe des militaires et leurs familles. Ces dernières années une certaine collaboration dans le domaine préventif s'est établie avec le Ministère de la santé. *Ex. : lutte antipaludique et lutte contre les maladies infectieuses (vaccinations).*

7 – Le cabinet paramédical fait partie du :

- a. Secteur sanitaire privé à but non lucratif
- b. Secteur sanitaire privé à but lucratif**
- c. Secteur sanitaire public
- d. Secteur traditionnel

9 – Le secteur sanitaire public est composé de :

- a. 2 réseaux
- b. 3 réseaux
- c. 4 réseaux**
- d. 5 réseaux



10 - La circonscription sanitaire rurale est le territoire :

- a. D'une commune
- b. D'un cercle
- c. D'un centre
- d. D'un caïdat



11 - L'offre de soins est composée :

- a. Des infrastructures sanitaires
- b. Des ressources financières
- c. Des équipements
- d. Des ressources humaines

OFFRE DE SOINS:

L'offre de soins est l'ensemble des ressources humaines, ensemble des infrastructures sanitaires relevant du secteur public ou privé, des installations de santé fixe ou mobile, ainsi que les moyens et fournitures pour assurer les soins et les prestations de santé.

12 - Le centre de santé rural niveau 2 est implanté pour une population de plus de :

- a. 15 000 habitants
- b. 20 000 habitants
- c. 25 000 habitants
- d. 30 000 habitants

CS 2 ^{ème} Niveau	Rural	Sous la responsabilité d'un médecin généraliste assisté par un(e) infirmier chef.	➤ CSR 1^{er} niveau ➤ Les soins obstétricaux d'urgence de base (SOUB) ; ➤ Les analyses biologiques de base requises pour le suivi de la santé des femmes enceintes et des malades chroniques ; ➤ Les examens d'échographie obstétricale. ➤ Lorsque le CS est implanté dans le chef-lieu d'un cercle administratif ne disposant pas de structure hospitalière, il est doté d'un module d'accouchement de 4 à 8 lits et délivre en plus : ➤ Des prestations d'urgence médicale de proximité ; ➤ Des soins bucco-dentaires ; ➤ Des consultations de santé mentale.	25 000 Hab
	Urbain		➤ Les soins obstétricaux d'urgence de base (SOUB) ; ➤ Les analyses biologiques de base requises pour le suivi de la santé des femmes enceintes et des malades chroniques ; ➤ Les examens d'échographie obstétricale. ➤ 4 à 8 lits d'accouchement au besoin ; ➤ Lorsque le CS est implanté dans le chef-lieu de la commune de rattachement ne disposant pas de structure hospitalière, on ajoute les soins bucco- dentaires et les consultations de santé mentale	50 000 Hab

13 - Le professionnel de santé peut être en position :

- a. D'activité
- b. De maladie
- c. De mise en disponibilité
- d. De détachement

14 - Les examens d'échographie sont assurés dans un :

- a. Centre de santé rural niveau 1
- b. Centre de santé urbain niveau 1
- c. Centre de santé urbain niveau 2
- d. Centre de santé rural niveau 2

CS 2 ^{ème} Niveau	Rural	Sous la responsabilité d'un médecin généraliste assisté par un(e) infirmier chef.	➤ CSR 1^{er} niveau ➤ Les soins obstétricaux d'urgence de base (SOUB) ; ➤ Les analyses biologiques de base requises pour le suivi de la santé des femmes enceintes et des malades chroniques ; ➤ Les examens d'échographie obstétricale. ➤ Lorsque le CS est implanté dans le chef-lieu d'un cercle administratif ne disposant pas de structure hospitalière, il est doté d'un module d'accouchement de 4 à 8 lits et délivre en plus : ➤ Des prestations d'urgence médicale de proximité ; ➤ Des soins bucco-dentaires ; ➤ Des consultations de santé mentale.	25 000 Hab
	Urbain		➤ Les soins obstétricaux d'urgence de base (SOUB) ; ➤ Les analyses biologiques de base requises pour le suivi de la santé des femmes enceintes et des malades chroniques ; ➤ Les examens d'échographie obstétricale. ➤ 4 à 8 lits d'accouchement au besoin ; ➤ Lorsque le CS est implanté dans le chef-lieu de la commune de rattachement ne disposant pas de structure hospitalière, on ajoute les soins bucco- dentaires et les consultations de santé mentale	50 000 Hab

15 - L'institut national d'hygiène est :

- a. Une structure spécialisée au réseau des ESSP
- b. Une structure spécialisée au réseau hospitalier
- c. Un établissement médicosocial
- d. Un établissement à caractère national

❑ REH :

Le réseau hospitalier est appuyé par les structures spécialisées suivantes :

- Le centre national et les centres régionaux de transfusion sanguine et d'hématologie ;
- L'institut national d'hygiène ;
- Le centre national antipoison et de pharmacovigilance ;
- Le centre national de radioprotection ;
- L'institut pasteur du Maroc.

16 - Le groupement sanitaire de territoire est :

- a. Établissement public
- b. Établissement privé à but non lucratif
- c. Établissement à caractère régional
- d. Établissement privé à but lucratif

▪ **Groupement sanitaire territorial (GST) :** Est un établissement public jouissant d'une personnalité morale et d'une autonomie financière créé dans le territoire de chaque région

17 - Le groupement sanitaire de territoire comporte :

- a. Les établissements hospitaliers militaires
- b. Les B.C.H
- c. Les établissements des soins de santé primaires
- d. Les établissements hospitaliers publics

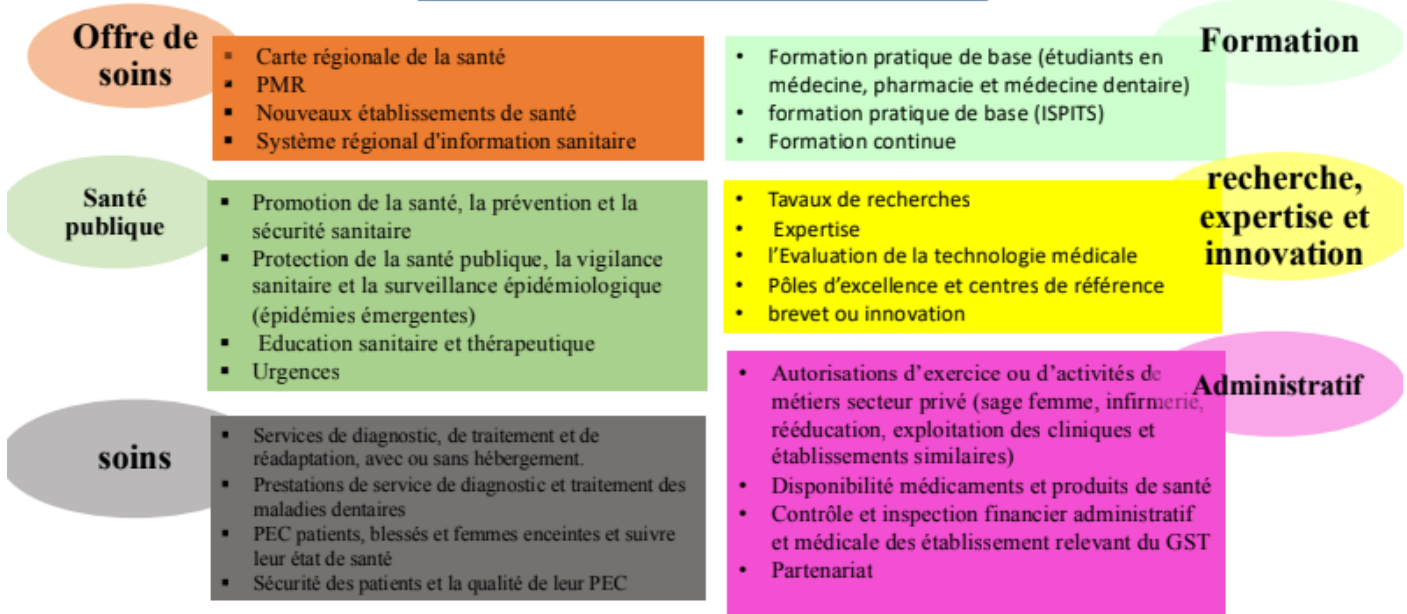
▪ **les GST englobent tous les établissements publiques sanitaires sous son influence à l'exception des :**

- ✓ **Etablissement publiques soumis à des textes législatifs et réglementaire spéciaux**
- ✓ **Les établissements sanitaires des FAR**
- ✓ **Les BMH**

18 - Le groupement sanitaire de territoire met en application la politique de l'État dans :

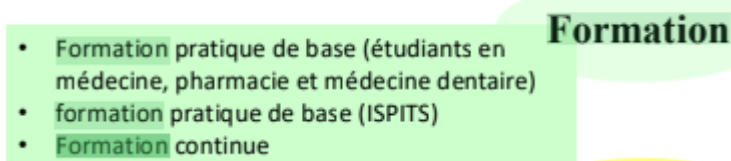
- a. Quatre domaines
- b. Cinq domaines
- c. Six domaines
- d. Sept domaines

Missions du GST (Article 4)



19 – Le groupement sanitaire de territoire assure :

- a. La formation initiale pour les étudiants de médecine et des ISPITS
- b. La formation pratique initiale pour les étudiants de médecine
- c. La formation pratique initiale pour les étudiants des ISPITS
- d. La formation continue des professionnels de santé du GST



20 – Le groupement sanitaire de territoire est dirigé par :

- a. Un conseil d'établissement
- b. Un conseil d'administration
- c. Un conseil de sages
- d. Un conseil consultatif

❖ Le Groupement est dirigé par un **Conseil d'Administration** (CA) et géré par un Directeur Général.

21 - Le centre hospitalier régional assure les prestations hospitalières de :

- a. Premier niveau
- b. Deuxième niveau
- c. Troisième niveau
- d. Quatrième niveau

3. ORGANISATION PAR TERRITOIRES DE SANTE :

Les régions sanitaires correspondent au ressort territorial des régions

Chaque région sanitaire est composée de deux ou plusieurs préfectures et provinces sanitaires

L'offre de soins au niveau d'une région sanitaire comporte :

- en plus des prestations de soins du niveau provincial et préfectoral;
- les prestations hospitalières du **deuxième niveau**.

Ce découpage constitue le champ d'intervention d'une **direction régionale** relevant du ministère de la santé



22. Les urgences médicales de proximité sont assurées dans un :

- A. Centre de santé rural niveau 2
- B. Hôpital de proximité
- C. Centre de santé rural niveau 2 implanté au chef-lieu du cercle
- D. Hôpital provincial

CS 2 ^{ème} Niveau	Rural	Sous la responsabilité d'un médecin généraliste assisté par un(e) infirmier chef.	➤ CSR 1^{er} niveau ➤ Les soins obstétricaux d'urgence de base (SOUB) ; ➤ Les analyses biologiques de base requises pour le suivi de la santé des femmes enceintes et des malades chroniques ; ➤ Les examens d'échographie obstétricale. ➤ Lorsque le CS est implanté dans le chef-lieu d'un cercle administratif ne disposant pas de structure hospitalière, il est doté d'un module d'accouchement de 4 à 8 lits et délivre en plus : ➤ Des prestations d'urgence médicale de proximité ; ➤ Des soins bucco-dentaires ; ➤ Des consultations de santé mentale.	25 000 Hab
----------------------------	-------	---	--	------------

23. Le centre hospitalier régional assure les urgences médicales :

- A. De proximité
- B. De base

C. Complètes

D. Spécialisées

III. Réseau Intégré des Soins d'Urgences Médicales (RISUM) :

- Urgences Médicales de Proximité (UMP) au niveau des CSR2 et CSU2
- Urgences Pré-hospitalières (UPH) (Secours de base, SMUR, Héli-SMUR)
- Urgences médico-hospitalières (UMH) (UMH **de base** au niveau HP et CHP, UMH **complètes** au niveau CHR et UMH **spécialisées** au niveau CHIR)

24. Le centre de diagnostic et de traitement des maladies respiratoires est une structure spécialisée d'appui au réseau :

A. Des établissements de soins de santé primaires

B. Hospitalier

C. RISUM

D. Médico-social

☐ RESSP :

☐ KESSP :

Les établissements de soins de santé primaires (ESSP) sont appuyés par des structures spécialisées qui assurent les activités relevant des programmes sanitaires. Ces structures comprennent :

- Les centres de référence pour la santé reproductive (CRSR) ;
- Les centres de diagnostic et de traitement des maladies respiratoires (CDTMR) ;
- Les laboratoires de santé publique (laboratoires de diagnostic épidémiologique et d'hygiène du milieu).

25. Le centre régional de transfusion sanguine est une structure spécialisée d'appui du réseau :

A. Des établissements de soins de santé primaires

B. Hospitalier

C. Médico-social

D. RISUM

☐ KESSB :

Les établissements de soins de santé primaires (ESSP) sont appuyés par des structures spécialisées qui assurent les activités relevant des programmes sanitaires. Ces structures comprennent :

- Les centres de référence pour la santé reproductive (CRSR) ;
- Les centres de diagnostic et de traitement des maladies respiratoires (CDTMR) ;
- Les laboratoires de santé publique (laboratoires de diagnostic épidémiologique et d'hygiène du milieu).

26. Les directions centrales du ministère de la Santé sont au nombre de :

- A. 4
B. 6
C. 8
D. 10



27. Les urgences pré-hospitalières sont assurées au niveau :

- A. D'un hôpital de proximité
B. D'un hôpital provincial

C. Des moyens de transport des blessés

D. De centre de santé urbain niveau 2

28. Face à un problème de santé publique, on adopte des approches dont :

A. L'approche épidémiologique

B. L'approche économique

C. L'approche médicale

D. L'approche individuelle

29. L'étude du financement des services de santé consiste à analyser :

A. Les sources du financement par structure

B. Les sources du financement par nature

C. Les ressources humaines

D. Les dépenses fonctionnelles de santé

30. L'assurance maladie est un dispositif chargé d'assurer un individu face à des risques :

A. Financiers d'accident

B. Financiers de soins

C. Financiers de vie

D. Financiers de perte d'emploi

31. La mortalité infantile est relative aux :

A. Décès de moins d'un an

B. Décès de 01 à 02 ans

C. Décès de 02 à 03 ans

D. Décès de 03 à 04 ans

32. La mortalité juvénile est relative aux :

A. Décès de moins de 05 ans

B. Décès de 01 à 05 ans

C. Décès de 05 à 10 ans

D. Décès de 10 à 15 ans

33. La mortalité maternelle est imputée à :

- A. La grossesse seulement
- B. La grossesse et à l'accouchement**
- C. L'accouchement seulement
- D. Ni à la grossesse ni à l'accouchement

34. La filière de soins est :

- A. Une organisation horizontale des soins
- B. Une organisation verticale des soins**
- C. Une organisation hiérarchisée du parcours de patient**
- D. Un réseau coordonné des soins

35. L'incidence d'une maladie est relative aux :

- A. Anciens cas enregistrés
- B. Nouveaux et aux anciens cas enregistrés
- C. Nouveaux cas enregistrés**
- D. Ni aux nouveaux ni aux anciens cas enregistrés

36. La létalité exprime les décès :

- A. Par âge
- B. Par sexe
- C. À cause d'une maladie**
- D. Intra hospitaliers

37. Le calcul du taux d'occupation moyen d'un hôpital dépend :

- A. Du nombre de malades admis
- B. Des journées d'hospitalisation**
- C. De la capacité litière**
- D. Du nombre de personnels

38. La protection sociale couvre :

- A. L'assurance du patrimoine
- B. L'assurance vie
- C. L'assurance maladie**
- D. Les allocations familiales**



39. Parmi les droits du patient, on a :

- A. Le droit à l'information
- B. Le droit à l'accès aux soins de qualité
- C. Le droit au respect du secret professionnel
- D. Le droit au consentement

40. Les règles professionnelles sont des règles :

- A. Sociales
- B. Déontologiques
- C. Juridiques
- D. Morales

